

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

До Вас звернулася мати дитини 14 років із скаргами на блідість шкіри, слабкість, зниження апетиту, головний біль, задишку та серцебиття при фізичному навантаженні.

Хворіє протягом останніх двох місяців, коли вперше визначались втома, слабкість та випадіння волосся.

Анамнез життя: ГРВІ три рази на рік,

Ви бачите: стан дитини середньої тяжкості, значна блідість шкіри та слизових оболонок, сухість та злущення шкіри, ангулярний стоматит, рідке витончене, сухе волосся, систолічний шум на верхівці серця при аускультації, АТ 100/60 мм рт ст. Живіт м'який, безболісний. Печінка та селезінка не збільшені. Фізіологічні відправлення без особливостей.

Клінічний аналіз крові

Показники	Дані пацієнта	Нормативні значення
Гемоглобін, г/л	74	110-140
Еритроцити, 10^{12} /л	2,67	3,7-4,9
Кольоровий показник, од	0,8	0,8-1,0
Тромбоцити, 10^9 /л	230	150 – 400
Лейкоцити, 10^9 /л	6,8	5-9
Паличкоядерні нейтрофіли, %	2	0,5-5
Сегментоядерні нейтрофіли, %	54	35-65
Лімфоцити, %	37	24-54
Еозинофіли, %	4	1-5
Моноцити, %	3	2-10
ШОЕ, мм/год	13	4-12
Ретикулоцити, ‰	5	3-12

Дані біохімічного аналізу крові

Рівень заліза в сироватці крові - 4,1 мкмоль/л (норма 9,0-21,5 мкмоль /л)

Загальна залізов'язувальна здатність сироватки крові (ЗЗЗС) - 85 мкмоль/л (норма 45.5-81.9 мкмоль/л)

Трансферин - 4,2 г/л (норма 2.0-3.6 г/л)

Рівень насиченості трансферину залізом -15% (норма 20.0-55.0 %).

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.		
1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитися, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи дасте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)

2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 14 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: скарги на блідість шкіри, слабкість, зниження апетиту, головний біль, задишку та серцебиття при фізичному навантаженні
2.2	Анамнез захворювання	Сказати: Як довго хворіє дитина? Очікувана відповідь: Хворіє протягом останніх двох місяців, коли вперше визначались втома, слабкість та випадіння волосся
2.3	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми/операції? Щеплення? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички та	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Оцінити загальний стан пацієнта, оцінити шкірні покриви	стан дитини середньої тяжкості, значна блідість шкіри та слизових оболонок, сухість та злущення шкіри, ангулярний стоматит, рідке витончене, сухе волосся
3.3	Клінічне (об'єктивне) обстеження пацієнта: перкусія та аускультация серця, пальпація живота з верифікацією виявлених патологічних змін	При аускультатії – систолічний шум на верхівці серця при аускультатії, АТ 100/60 мм рт ст. Живіт м'який, безболісний. Печінка та селезінка не збільшені .
4.Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	гіпохромна анемія, норморегенераторна(ретикулоцити в нормі)
4.2	Визначити результат біохімічного аналізу крові	знижений рівень заліза в сироватці крові та рівня насиченості трансферину залізом, підвищення загальної залізов'язувальної здатності сироватки крові, трансферріна.
4.3	Визначити провідний синдром	Сказати: анемічний, сидеропенічний

4.4	Встановити клінічний діагноз	Залізодефіцитна анемія, середнього ступеня тяжкості, гіпохромна, норморегенераторна
5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Госпіталізація у гематологічне відділення та призначення терапії препаратами заліза (мальтофер 100 мг 3 р в д), раціональне харчування.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Повноцінне харчування (м'ясо тварин)
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Ви повинні знати про можливі ускладнення здфц анемії – порушення процесів життєдіяльності організму, запаморочення, гіпоксія.